



SEPSİS SEPTİK ŞOK

KRONİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

HEMŞİRE YILDIZ ÖĞÜT

HEMŞİRE ELANUR KESKİN

Sepsis

Sepsis:

- Çeşitli patojen ve konak faktörlerine, uygun tedavinin zamanında tanınmasına ve sağlanmasına bağlı olarak orta (örneğin %10) ile önemli (örneğin > %40) arasında değişen mortalite riski olan bir hastalık spektrumunu temsil eder.
- SIRS ile birlikte enfeksiyon (bakteri, virus ve mantar) olduğunun kanıtlanmasıdır.
- Enfeksiyon kanıtlanmamış olsa da sepsisli hastanın klinik belirti ve bulguları önemli kriterdir. (Khilnani P, Deopujari S and Carcillo J. Recent advances in sepsis and septic shock. Indian J Pediatr 2008;75(8):821-30).

Ağır sepsis:

- Sepsis ile birlikte,
 - ❖ Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)
 - ❖ Kardiyovasküler organ fonksiyon bozukluğu,
Bunlar yok ise
 - ❖ iki ya da daha fazla organ fonksiyon bozukluğunun olması ağır sepsis olarak tanımlanır.

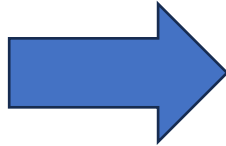
Sepsis

Septik Şok:

- Sepsis gelişen hastada başka bir nedene bağlı olmayan ve yeterli sıvı tedavisine rağmen devam eden kardiyovasküler disfonksiyondur. Dolaşım ve/veya hücrel metabolizmanın ciddi anormallikleri nedeniyle önemli ölçüde artmış mortaliteye sahip sepsis alt kümesidir. (Septic Shock: 2012. Crit Care Med 2013; 41(2):580-637.)
- Kalıcı hipotansiyonu içerir (yeterli hacim resüsitasyonuna rağmen ortalama arter basıncını ≥ 65 mm Hg ve serum laktat düzeyini > 18 mg/dL [2 mmol/L] seviyesinde tutmak için vazopressörlere ihtiyaç duyulması olarak tanımlanır. (Aitken LM, Williams G, Harvey M, Blot S, Kleinpell R, Labeau S, et al. Nursing considerations to complement the Surviving Sepsis Campaign guidelines. Crit Care Med 2011; 39(7):1800-18.)

Çocuk hastalarda hipotansiyon ya da inotrop ihtiyacı olmadan;

- Açıklanamayan metabolik asidoz,
- Serum laktat artışı,



kriterlerinden ikisinin olması **kardiyovasküler disfonksiyon** göstergesidir

- Uzamış kapiller dolum zamanı
- Santral-periferik ısı farkının 3°C 'den fazla olması

(Goldstein B, Giroir B, Randolph A. International pediatric sepsis consensus conference: Definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005;6(1):2-8.)

Sepsis ve Septik Şokun Etiyolojisi

- Septik şok vakalarının çoğu hastanede edinilen gram negatif basil veya gram pozitif koklardan kaynaklanır ve sıklıkla bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ve kronik ve güçten düşürücü hastalıkları olan hastalarda görülür
- Nadiren Candida veya diğer mantarlardan kaynaklanır .
- Yakın zamanda ameliyat geçirmiş hastalarda septik şokun nedeni olarak ameliyat sonrası enfeksiyondan şüphelenilmelidir.
- Stafilokok ve streptokok toksinlerinin neden olduğu benzersiz, nadir bir şok biçimine **toksik şok sendromu** denir (Dellinger RP, Levy MM, Rhodes

A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Crit Care Med 2013; 41(2):580-637.)

Septik şok;

- Daha çok yenidoğanlarda
- Yaşlı yetişkinlerde
- Hamile kişilerde görülür.

Yatkınlık yaratan faktörler şunlardır:

- Şeker hastalığı
- Siroz
- Lökeni(özellikle kanser veya sitotoksik ilaçlarla tedaviyle ilişkili olanlar)
- İnvaziv cihazlar (endotrakeal tüpler, vasküler veya idrar kateterleri, drenaj tüpleri ve diğer yabancı maddeler dahil)
- Antibiyotik veya kortikosteroidlerle daha önce tedavi görmüş olmak
- Yakın zamanda hastaneye yatış (özellikle yoğun bakım ünitesinde)
- Enfeksiyonun yaygın nedensel bölgeleri arasında akciğerler ve idrar, safra ve gastrointestinal sistemler

yer alır.

Sepsis ve Septik Şokun Belirtileri ve Bulguları

Sepsiste (septik şok olmadan),

- Hastalarda tipik olarak ateş,
- Taşikardi,
- Diyaforez
- Taşipne görülür;
- Kan basıncı normal kalır.
- Etken enfeksiyonun diğer belirtileri mevcut olabilir.

(Humar A, Ostromecki A, Drenfeld J, Marshall JC, Lazar N, Houston PC, et al. Prospective randomized trial of 10% povidone-iodine versus 0.5% tincture of chlorhexidine as cutaneous antisepsis for prevention of central venous catheter infection. Clin Infect Dis 2000; 31(4):1001-)

- Sepsis belirtileri ve bulguları belirsiz olabilir ve sıklıkla diğer bozuklukların belirtileriyle karıştırılabilir.
- İmmünsüpresyonlu hastalarda veya postoperatif hastalarda sepsis klinik belirtilerini tanımak özellikle zor olabilir.
- Sepsis kötüleştikçe veya septik şok geliştikçe, özellikle yaşlı yetişkinlerde veya çok gençlerde erken bir belirti, kafa karışıklığı veya azalmış uyanıklık olabilir.

Kan basıncı düşer

- Cilt paradoksal olarak sıcaktır

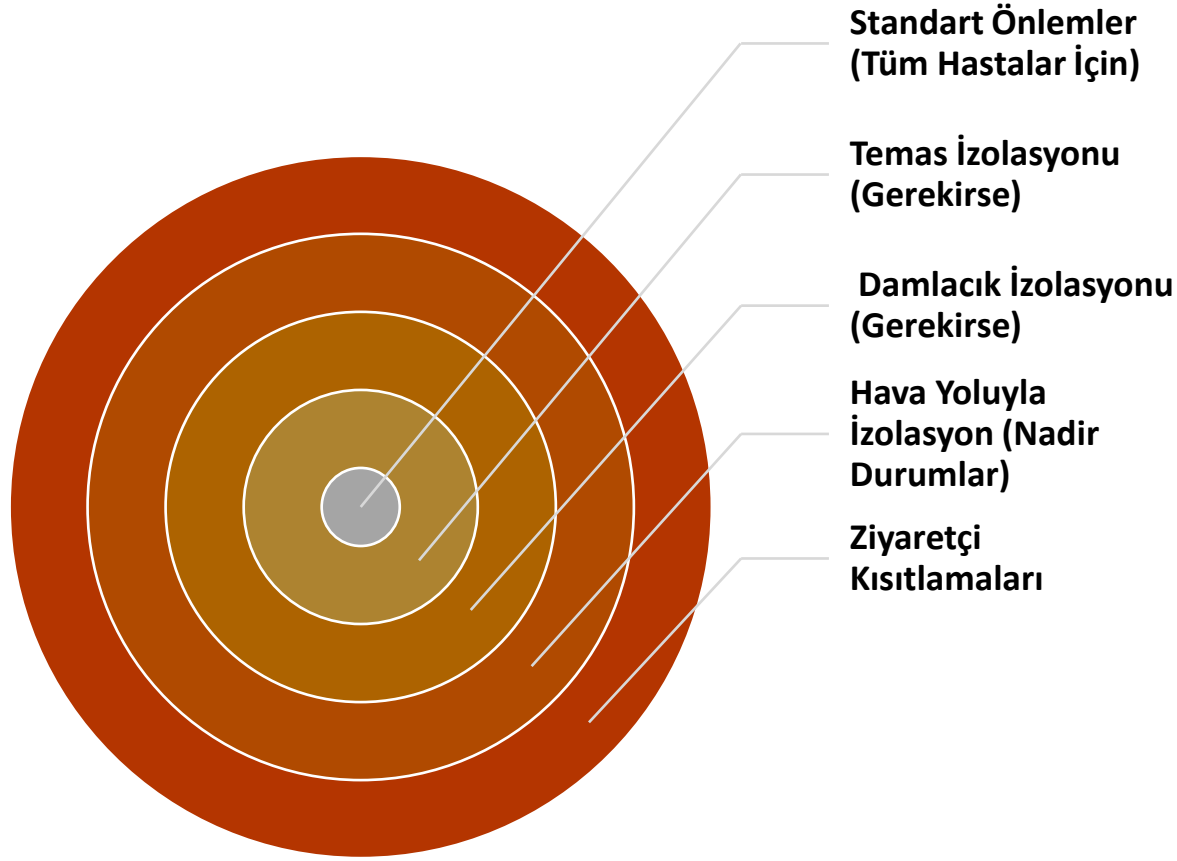
Ekstremiteler soğuk ve soluk hale gelir

- Periferik siyanoz ve beneklenme olur.

Organ işlev bozukluğu

- İlgili organa özgü ek semptomlara ve belirtilere neden olur (örn. oligüri, dispne).

MEDİKAL İZOLASYON YÖNTEMLERİ



Sepsisin kendisi bulaşıcı değildir, ancak altta yatan enfeksiyon etkeni (örneğin bakteri, virüs, mantar) bulaşıcı olabilir. Bu nedenle **medikal izolasyon önlemleri**, hastalığa neden olan ajana ve bulaş yoluna göre planlanır.



Standart Önlemler (Tüm Hastalar İçin)



El hijyeni: Hasta ile temas öncesi ve sonrası el yıkama veya el antiseptiği kullanımı.



Eldiven kullanımı: Kan, vücut sıvısı, sekresyon/ekskresyonlarla temas ihtimali varsa mutlaka giyilir.



Önlük ve maske: Sıçrama riski olan işlemlerde kullanılır.



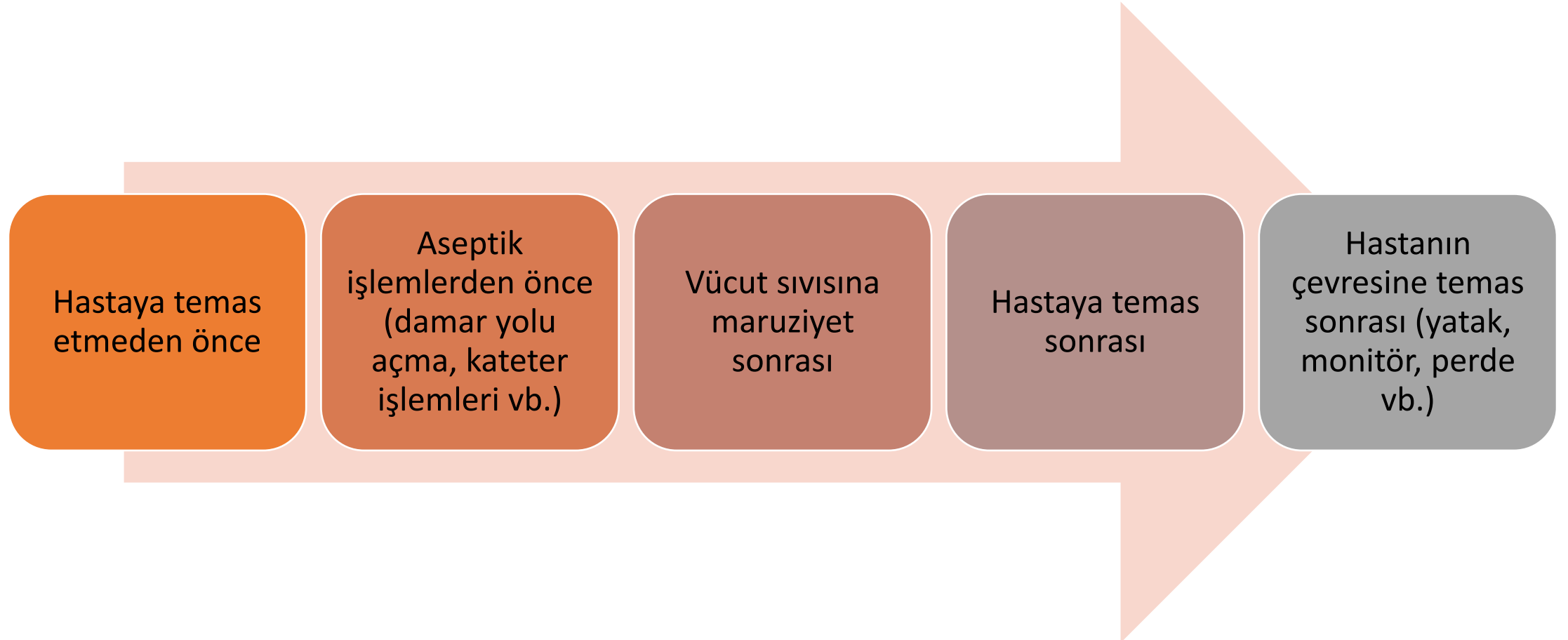
Güvenli iğne kullanımı ve atık yönetimi.



Ekipman dezenfeksiyonu: Tıbbi cihazlar her hastadan sonra temizlenir.

El Hijyeni Ne Zaman Yapılmalı? (WHO “5 Indications for Hand Hygiene”)

Sepsisli hastalarda 5 durumda mutlaka el yıkama veya antiseptik ile el hijyeni yapılmalıdır



Hangi Durumda Sabun + Su, Hangi Durumda Antiseptik?

Durum	Kullanılacak Yöntem
Görünür kir/pislik varsa	Sabun + su ile yıkama
C. difficile veya norovirüs gibi sporlu patojen şüphesi varsa	Sabun + su ile yıkama (alkol etkisiz)
Diğer tüm durumlar (görünür kir yoksa)	Alkol bazlı el antiseptiği (ABHR)

Doğru El Yıkama Adımları (Sabun + Su)



Elleri ıslat

Sabunu al ve avuç içlerine uygula

Avuç içlerini birbirine sür

Sağ el ile sol elin üstünü ve parmak aralarını ovala (ve tersi)

Parmak aralarını temizle

Parmak sırtlarını ovala

Baş parmakları temizle

Tırnak uçlarını avuç içinde döndürerek yıka

Bileklere kadar ovala

Akan suyla durula

Kâğıt havluyla kurula ve musluğu aynı havluyla kapat

🕒 Süre: En az **40–60**
saniye

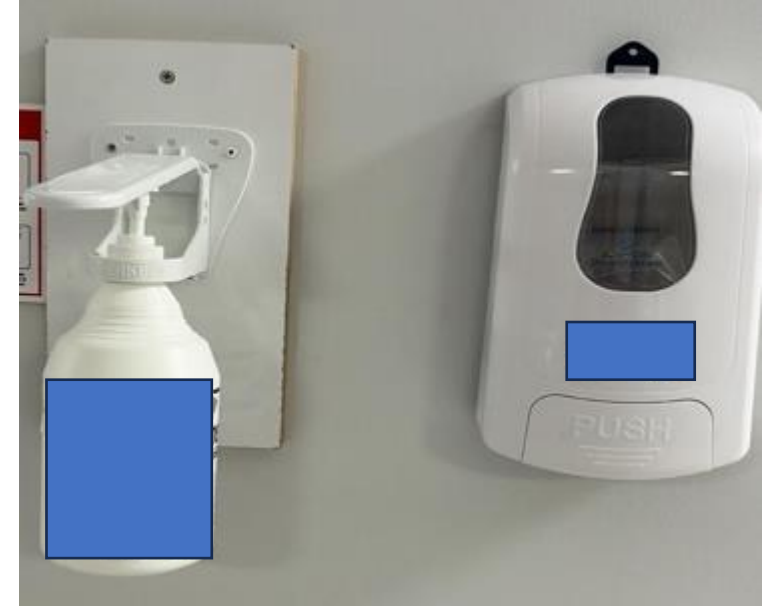
Alkol Bazlı El Antiseptiđi Kullanım Adımları

Avuca yeterli miktarda antiseptik al (yaklaşık 3–5 ml)

Elin tüm yüzeylerine yay

Yukarıdaki el yıkama hareketlerini **sabunsuz** tekrarla

Eller tamamen kuruyana kadar ovalamaya devam et



? Süre: En az **40–60 saniye**

Temas İzolasyonu (Gerekirse)

- Eğer sepsise neden olan ajan **temasla bulaşan** bir patojene (örneğin MRSA, VRE, Clostridium difficile):
- Eldiven ve önlük giyilir.
- Hasta mümkünse **tek kişilik odada** izole edilir.
- Oda dışına çıkışı sınırlandırılır.
- Ortak ekipmanlar hastaya özel olmalıdır.



Timsit JF, Schwebel C, Bouadma L, Geffroy A, Garrouste-Orgeas M, Pease S, et al. Chlorhexidine-impregnated sponges and less frequent dressing changes for prevention of catheter-related infections in critically ill adults: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301(12):1231-41.

Damlacık İzolasyonu (Gerekirse)

- Eğer etken **damlacık yoluyla bulaşıyorsa** (örneğin Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis):
- **Cerrahi maske** kullanılır (hasta ve sağlık personeli).
- Hasta mümkünse **tek kişilik odada** tutulur.
- Ziyaretçiler maske takmalıdır.

Timsit JF, Schwebel C, Bouadma L, Geffroy A, Garrouste-Orgeas M, Pease S, et al. Chlorhexidine-impregnated sponges and less frequent dressing changes for prevention of catheter-related infections in critically ill adults: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301(12):1231-41.



Hava Yoluyla İzolasyon (Nadir Durumlar)

- Sepsise neden olan ajan **hava yoluyla bulaşan** bir mikrop ise (örneğin Tüberküloz, Suçiçeği, Kızamık):
- **N95 / FFP2/3 maske** kullanılır.
- **Negatif basınçlı oda** gerekir.
- Hasta dışarı çıkarken cerrahi maske takmalıdır.

Timsit JF, Schwebel C, Bouadma L, Geffroy A, Garrouste-Orgeas M, Pease S, et al. Chlorhexidine-impregnated sponges and less frequent dressing changes for prevention of catheter-related infections in critically ill adults: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301(12):1231-41.



Ziyaretçi Kısıtlamaları

- Ziyaretçilere izolasyon önlemleri anlatılır.
- Kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven, önlük) sağlanır.
- Hasta ile doğrudan temas sınırlanır.

DİĞER HASTALARA VE KENDİMİZE BULAŞIN ÖNLENMESİ SONUÇ

El hijyeni

Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı

İzolasyon önlemleri

Steril ve temiz ortam sağlama

Tıbbi cihazların aseptik kullanımı

İzolasyon Kararını Etkileyen Faktörler:

- Sepsis etkeni (bakteri, virüs vs.)
- Etkenin bulaş yolu (temas, damlacık, hava)
- Hastanın genel durumu
- Hastanenin izolasyon olanakları

Etken	Bulaş Yolu	İzolasyon Tipi
MRSA	Temas	Temas izolasyonu
Neisseria meningitidis	Damlacık	Damlacık izolasyonu
Tüberküloz	Hava	Hava yolu izolasyonu
C. difficile	Temas (spor formu)	Temas izolasyonu + sabunla el yıkama

Sepsis ve Septik Şok Tanısı

- Kan basıncı (BP),
- Kalp hızı
- Oksijen takibi
- Diferansiyel, elektrolit paneli, kreatinin ve laktat içeren tam kan sayımı (CBC)
- İnvaziv santral venöz basınç (CVP),
- Arteriyel oksijenin kısmi basıncı (PaO2)
- Santral venöz oksijen satürasyonu (ScvO2) okumaları
- Cerrahi hastalardaki yaralar dahil olmak üzere kan, idrar ve

diğer potansiyel enfeksiyon bölgelerinin kültürleri

(Khilnani P, Deopujari S and Carcillo J. Recent advances in sepsis and septic shock. Indian J Pediatr 2008;75(8):821-30).

**Sistemik
İnflamasyon
Belirtileri**

➤ Bilinen bir enfeksiyonu olan bir hastada sistemik inflamasyon veya organ disfonksiyonu belirtileri geliştiğinde sepsis şüphesi doğar .

➤ C-reaktif protein



kan seviyeleri şiddetli sepsiste sıklıkla yükselir

➤ prokalsitonin

TANIYI KOLAYLAŞTIRABİLİR, ANCAK SPESİFİK DEĞİLDİR.

➤ Sepsisin cerrahi veya gizli bir nedeni olduğundan şüphelenilen hastalarda, şüphelenilen kaynağa bağlı olarak

❖ Ultrasonografi (örneğin, Şok ve Hipotansiyon İçin Hızlı Ultrason (RUSH) Muayenesi),

❖ BT

❖ MRI gerekebilir.

TANI KLİNİKTİR.

- Organ disfonksiyonunu mümkün olduğunca erken tespit etmek önemlidir.
- Sepsis'in erken tespiti için bir dizi puanlama sistemi geliştirilmiştir, ancak ardışık organ yetmezliği değerlendirme puanı (SOFA puanı) ve hızlı SOFA puanı (qSOFA) ölüm riski açısından doğrulanmıştır ve kullanımı nispeten basittir.

➤ **qSOFA puanı;**

❖ kan basıncına,

❖ solunum hızına

❖ Glasgow Koma Ölçeği'ne dayanır

(Leclerc F, Leteurtre S, Duhamel A, Grandbastien B, Proulx F, Martinot A, et al. Cumulative influence of organ dysfunctions and septic state on mortality of critically ill children. Am J Respir Crit Care Med 2005;171(4):348- 53.)

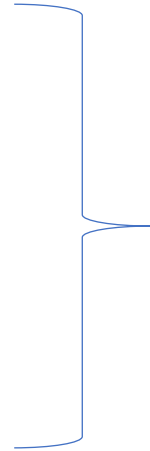
LABORATUVAR SONUÇLARINI BEKLEMİYİ GEREKTİRMEZ.

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) şüpheli enfeksiyonlu hastalar için

➤ qSOFA skoru,

➤ SIRS kriterleri

➤ SOFA skorundan



hasta mortalitesi öngörücüsüdür.

qSOFA kriterleri;

➤ Solunum hızı $\geq$ dakikada 22 nefes

➤ Değişen zihniyet (Glasgow Koma Ölçeği)
tutulmalıdır

➤ Sistolik kan basıncı ≤ 100 mm Hg

≥ 2'sine sahip hastalar daha ileri klinik ve laboratuvar incelemesine tabi

Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) Puanı

- Tam kan sayımı,
 - Arteriyel kan gazları (AKG),
 - Göğüs röntgeni,
 - Serum elektrolitleri,
 - BUN (kan üre azotu), kreatinin,
 - Kısmi karbondioksit basıncı (PCO₂)
 - Karaciğer fonksiyonu
- izlenir.

Tedaviyi yönlendirmeye yardımcı olmak için;

- serum laktat düzeyleri,
- ScvO₂ veya her ikisi belirlenebilir.
- WBC sayısı azalabilir ($< 4.000/\text{mcL}$ [$< 4 \times 10^9 /\text{L}$]) veya artabilir ($> 15.000/\text{mcL}$ [$> 15 \times 10^9 /\text{L}$])
- Polimorfonükleer lökositler %20 kadar düşük olabilir.
- Eş zamanlı kortikosteroid kullanımı WBC sayısını yükseltebilir ve böylece hastalıktaki eğilimler nedeniyle WBC değişikliklerini maskeleyebilir.

➤ Sepsis: “**enfeksiyona karşı disregüle konak yanıtına bağlı organ disfonksiyonu**” olarak tanımlanmaktadır. Kanıtlanmış enfeksiyonun yanında yaşamı tehdit eden organ yetmezliği” olarak da belirtilmektedir

➤ Sepsis tanısı için aranan organ disfonksiyonu SOFA skorunda 2 puan veya daha fazla düşme ile tanımlanabilir.

➤ SOFA skorunda kullanılan kriterler:

❖ PaO₂/FiO₂ oranı,

❖ Bilinç değerlendirmesi (GKS),

❖ Ortalama Arter basıncı (OAB), vazopressör gereksinimi ve dozları,

❖ Kreatinin değeri, idrar çıkışı,

❖ Bilirubin düzeyi,

❖ Trombosit sayısı

*Toplam skor 0-24 arasında değerlendirilmektedir.

➤ Septik şok ise ;

❖ “Yeterli sıvı resüsitasyonuna karşın OAB (ortalama arteriyel basınç) değerinin 65 mmHg ve üzerinde tutulabilmesi için vazopressör gerekliliği

❖ Serum laktat düzeyinin 2 mmol/L üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır.

Tablo: SOFA skoru				
	1*	2	3	4
Solunum				
PaO ₂ /FiO ₂ mmHg	≤ 400	≤ 300	≤ 200 ve	≤ 100 ve
	MV var/yok	MV var/yok	MV var	MV var
Kardiyovasküler				
Hipotansiyon	OAB < 70 mmHg	Dopamin ≤ 5 ve dobutamin**	Dopamin > 5 ya da adrenalin ≤ 0.1 ya da noradrenalin ≤ 0.1**	Dopamin ≥ 15 ya da adrenalin > 0.1 ya da noradrenalin > 0.1**
Karaciğer				
Bilirubin mg/dL	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	> 12
Koagülasyon				
Trombosit 10 ³ /mm ³	≤ 150	≤ 100	≤ 50	≤ 20
Böbrek				
Kreatinin mg/dL ya da idrar debisi	1.2-1.9	2.0-3.4	3.5-4.9 Debi ≤ 500 mL/gün	> 5 Debi ≤ 200 mL/gün
Nörolojik				
GKS	13-14	10-12	6-9	< 6
* Bu sınırın ötesindeki değerler 0 puan alır.				
** En az 1 saat µg/kg/dakika dozunda verilmiş olmalı.				
MV: Mekanik ventilasyon, OAB: Ortalama arter basıncı, GKS: Glasgow koma skoru.				

TANI

- Hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi
- İyi bir öykü alınması,
- Hemokültürde mikroorganizmanın saptanmasından daha önemlidir.
- Laboratuvar bulguları tanıyı destekler.
- Sepsis düşünülen hastaların kan kültürü, idrar kültürü, ishali varsa dışkı kültürü uygun şekilde alınmalıdır.
- Ayrıca enfeksiyon odağı biliniyorsa buralardan kültürler (periton, plevra, abse vb.),
- Santral sinir sistemi enfeksiyon bulguları varsa beyin omurilik sıvısı (BOS)
- Mevcutsa kateter kültürleri alınmalıdır.
- Kültür alınmadan önce antibiyotik uygulanmamalıdır.
- Sepsis yönetim rehberinde, kan kültürünün en az biri perkütan ve biri de kateterden olacak şekilde alınması, bu işlemin

antibiyotik tedavisini geciktirmemesi gerektiği bildirilmektedir. (Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: International

TEDAVİ

Sepsis tedavisi antibiyotik ve destek tedavisi şeklinde düzenlenir.

Antibiyotik tedavisinde gecikmenin her saat mortaliteyi %12 artırdığı bilinmektedir.

Antibiyotik tedavisi;

- Genellikle enfeksiyon odağına,
- Hastanın yaşına,
- Risk faktörüne,
- Sepsiste destek tedavi antibiyotik tedavisinden daha önemli yer tutar.
- Destek tedavinin sağlanmasında hemşireler hastanın prognozunun iyileştirilmesinde ciddi katkılar sağlar.

(Çıtak A. Çocuklarda septik şok ve tedavisi. 3.Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 2013.)

Sepsis Tedavisinde İş Birliği Yapılan Uzmanlar ve Roller

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

- Enfeksiyonun kaynağını belirler.
- Uygun **antibiyotik** veya **antifungal** tedavisini planlar.
- Antibiyotik duyarlılık testlerini yorumlar. (Shime N, Kawasaki T, Saito O, Akamine Y, Toda Y, Takeuchi M, et al. Incidence and risk factors for mortality in paediatric severe sepsis: results from the national paediatric intensive care registry in Japan. Intensive Care Med 2012;38(7):1191-7)

Yoğun Bakım Uzmanı / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

- Sepsisli hastaların **yoğun bakım yönetimini** üstlenir.
- Solunum desteği, sıvı resüsitasyonu, damar içi ilaçlar (vazopresörler) gibi hayati destekleri **düzenler.** (Yıldızdaş D, Yapıcıoğlu H, Tümgör G, Erbey F. Çocuk yoğun bakım ünitesi'nde sepsis nedeni ile izlenen hastalarda poliklonal intravenöz immünglobülin tedavisi mortaliteyi azaltıyor mu?. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:136-41.)

Surviving Sepsis Campaign (SCC) tarafından Mart 2026'da yayınlanan güncel sepsis kılavuzu (2026 SSC Guidelines), 2021 kılavuzlarını temel alarak 46 yeni öneri eklemiş ve toplam 129 maddelik, kanıta dayalı daha spesifik standartlar getirmiştir

(TARD - Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ©2001-2026 /SSC 2026 Sepsis Kılavuzu: Güncel Öneriler İnfografikte)

🔍 1 · Tarama ve Erken Yönetim

- Kurumsal sepsis kodu protokolü uygula
- **NEWS/NEWS2** tarama skoru — qSOFA'ya üstün
- Antibiyotik başlamadan önce kan kültürü al
- Septik şokta antibiyotik **≤1 saat** içinde
- Olası sepsiste (şok yoksa) **≤3 saat** içinde
- Kaynak kontrolü **≤6 saat** içinde
- Hastane öncesi antibiyotik: bekleme **>60 dk** + şok varsa başla



2 · Antimikrobiyal Yönetim

- ★ **Beta-laktam uzatılmış infüzyon** — güçlü öneriye yükseltildi; 1000 hastada 25 daha az ölüm
- MDR riski yoksa geniş spektrumdan kaçın
- Anaerobik kapsam yalnızca risk faktörü varsa
- Ampirik antifungal tedavi genel olarak önerilmez
- Kültür sonucu gelince **de-eskalasyon** yap (güçlü öneri)
- Düşük direnç prevalanslı YBÜ'lerde SDD uygulanabilir

3 · Hemodinami

- İlk 3 saatte **$\geq 30 \text{ mL/kg}$** dengeli kristalloid kullanılmalı; HES ve jelatin kullanılmamalı
- Dinamik sıvı yönlendirme: SVV, PPV, pasif bacak kaldırma
- OAB hedefi **$\geq 65 \text{ mmHg}$** ; 65 yaş ve üzerinde **60–65 mmHg**
- Santral erişim beklenmeksizin periferden vazopressör başlanabilir
- Vazopressör sırası: **noradrenalin → vazopressin → epinefrin**
- Akut resüsitasyon sonrasında aktif sıvı çıkışını değerlendir

⇒ 4 · Solunum Desteği

- Koyu ten rengi veya şokta pulse oksimetre yanıltıcı olabilir; arteriyel kan gazı tercih et
- **HFNO**, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$ olgularda standart oksijen tedavisine ve NIMV'ye üstün
- Entübe olmayan hipoksemik hastalarda yüzüstü pozisyon denenebilir
- ARDS: TV **6 mL/kg İVA**, plato basıncı $\leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$
- ARDS dışı MV: TV **6–8 mL/kg İVA**
- Orta-ağır ARDS'de yüzüstü ventilasyon günde **>12 saat**; artımlı PEEP titrasyonundan kaçın

🔑 5 · Adjuvan ve Destekleyici

- › Septik şokta **kortikosteroid** tedavisi önerilebilir (koşullu)
- › C vitamini, D vitamini, probiyotik, IVIG, kan purifikasyonu — **önerilmez**
- › Kan glukozu **≥ 180 mg/dL** olduğunda insülin başla
- › Kısıtlayıcı transfüzyon stratejisi (güçlü öneri)
- › Erken enteral beslenme (72 saat içinde)
- › **DMAH** ile VTE profilaksisi — standart heparine tercih (güçlü)



6 · Bakım Hedefleri ve Uzun Dönem

- › Erken bakım hedeflerini ve ileri tedavi planını hasta/aile ile görüş; (güçlü)
- › Palyatif bakım konsültasyonunu erken gündeme al
- › YBÜ çıkışında yapılandırılmış devir teslim
- › MV >48 saat: erken mobilizasyon ve yapılandırılmış rehabilitasyon
- › **PICS** taraması — fiziksel, bilişsel ve psikolojik boyutlar
- › Psikolojik müdahale semptom varsa önerilebilir; YBÜ sonrası takip için kanıt yetersiz

SSC 2026, sepsis yönetimini iki temel eksen üzerine kuruyor: **erken ve kararlı eylem** ile **bireyselleştirilmiş titrasyon**. İlk eksen için sınırlar nettir — septik şokta antibiyotik bir saat içinde, kaynak kontrolü altı saat içinde, beta-laktam uzatılmış infüzyonla; bu üç ilke artık tartışmalı değil. İkinci eksen ise kılavuz klinisyene belirli bir hareket alanı tanıyor: liberal ya da kısıtlayıcı sıvı stratejisi klinik duruma göre seçilebilir, yaşa göre OAB hedefi ayarlanabilir, MDR riskine göre antimikrobiyal kapsam daraltılabilir. Adjuvan tedaviler cephesinde ise umut verici görünen birçok ajanın büyük çalışmalarda fayda gösterememesi, kılavuzun "ne kullanılmamalı" mesajını netleştiriyor.

! BU KILAVUZUN ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLERİ

- **Beta-laktam Uzatılmış İnfüzyon** **YÜKSELTİLDİ**
18 RKÇ, 9108 hasta — koşullu öneriden güçlü öneriye yükseltildi. 1000 hastada 25 daha az ölüm. Yükleme dozunun ardından uzatılmış veya sürekli infüzyon uygulanmalı.
- **≥65 Yaş OAB Hedefi: 60–65 mmHg** **YENİ**
65 çalışması (2463 hasta) ve OPTPRESS: 90 günlük mortalite benzer, daha az vazopressör ihtiyacı. 65 yaş ve üzerinde daha düşük OAB hedefi artık kanıt destekli.
- **HFNO Önceliği Netleşti** **YENİ**
 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$ olgularda HFNO, hem standart oksijen tedavisine hem NIMV'ye tercih edilmeli. Entübe olmayan hastalarda yüzüstü pozisyon ek bir seçenek olarak eklendi.
- **Hastane Öncesi Antibiyotik** **YENİ**
Septik şok ve hastaneye ulaşma süresi > 60 dk olduğunda ambulans veya hava ambulansında antimikrobiyal tedavi başlanabilir. Koşullu öneri; NEWS2 tarama protokolü ile birlikte uygulanmalı.
- **Dengeli Kristalloid ve Sıvı Stratejisi** **REVİZE**
Dengeli kristalloid, %0,9 NaCl yerine tercih edilmeli (travmatik beyin hasarı hariç). Liberal ve kısıtlayıcı sıvı stratejisi mortalite açısından eşdeğer; hasta özelliklerine göre seç.
- **Uzun Dönem Sonuçlar ve PICS** **YENİ**
Fiziksel rehabilitasyon, PICS taraması ve psikolojik destek ilk kez koşullu öneri düzeyinde yer aldı. YBÜ sonrası takip kliniği ve bilişsel rehabilitasyon için kanıt henüz yetersiz.

RUTİN KULLANIMI ÖNERİLMİYEN TEDAVİLER

C Vitamini

Büyük çalışmalarda (LOVIT dahil) mortaliteye anlamlı etkisi gösterilemedi. Koşullu aleyhine öneri.

D Vitamini

Sepsis tedavisi amacıyla önerilmez. VIOLET alt grubunda yüksek dozda mortalite artış sinyali saptandı.

HES / Jelatin

Sıvı resüsitasyonunda kristalloid tercih edilmeli. HES kullanımından güçlü aleyhine öneri ile kaçınılmalı.

Kan Purifikasyonu

Hemoperfüzyon, yüksek doz hemofiltrasyon ve plazma değişimi önerilmez. Koşullu aleyhine öneri.

SEPSİSTE HEMŞİRELİK BAKIMI

❖ HAVA YOLU AÇIKLIĞINI SAĞLAMA VE SÜRDÜRME

- Hava yolu açıklığının sağlanması için pozisyon verilmesi,
- Airway kullanılması
- Hastanın durumuna göre gerekiyorsa spontan solunumu olmayan hastada entübasyon uygulanmasına karar verilir.
- Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) bulguları (mekanik ventilasyon tedavisi sırasında dispne, takipne, hipoksemi, akciğer kompliyansında azalma vd.) yakından gözlenmeli ve ARDS şüphesinin olduğu durumlarda hekimin karar verdiği uygun mod'ta (mod seçimi hekimlerin tedavi prensiplerine göre değişmektedir) ventilasyon uygulanarak hastaya prone pozisyon verilmelidir.
- Entübe olarak takip edilen hastalarda en önemli amaç hastanın mekanik ventilatörden en kısa zamanda ayrılmasıdır. Bu amaçla hastanın mekanik ventilatörden ayrılmasında hemşirenin yakın gözlemi, uygun miktarda FiO2 düzeyini belirlemesi ve zaman zaman basınç modlarını değiştirebilmesi için hemşireye fırsat verilmelidir.
- Sepsis ile ilişkili ciddi solunum yetmezliği ve ciddi septik şok olgularında ECMO tedavisi uygulanabilir.
- Hava yolu açıklığını engelleyen sekresyonların olması durumunda, gerektiğinde orotrakeal veya nazotrakeal aspirasyon yapılır.

❖ OKSİJEN VERME

- Solunum sıkıntısı olduğunda veya hipoksi geliştiğinde en önemli tedavi yöntemi ve ilk yapılması gereken girişim dokuların oksijenlenmesini sağlamaktır.
- Oksijenin hangi yolla verileceğine hastanın durumuna göre karar verilir.
- Spontan solunumu olan hastaya solunumu rahat ise basit oksijen maskesi ile oksijen verilebilir.
- Solunum yetmezliği bulguları (dispne, taşipne, burun kanatlarının solunuma katılması, interkostal/subkostal çekilmeler vd.) gözlenen spontan solunumu olan hastalarda, %100 oksijen için geri dönüşümsüz oksijen maskesi kullanılarak oksijen verilir.
- Hasta hipoksemik ise CPAP uygulanabilir.
- Hastanın solunumu CPAP ile düzelmez ise solunum işinin artması, solunum kaslarında yorgunluk, bilinç değişikliği ve oksijene rağmen ağır hipoksi ve dolaşım bozukluğu bulguları (solukluk, siyanoz, cuttis marmaratus, kapiller dolum zamanının >2 sn vd.) görüldüğünde erken mekanik ventilasyon için hazırlıkların yapılması gerekir.

❖ MONİTÖRİZASYON

Sepsiste hastanın takibi ve tedaviye cevabın izlenmesinde monitörizasyon önemlidir.

- Hastaların kalp hızı,
- Kan basıncı,
- Solunum sayısı,
- EKG
- Oksijen saturasyonu monitörize edilerek izlenmelidir.
- Monitörizasyon hastanın yanıtına göre arttırılabilir.
- Sıvı veya inotrop desteğine yanıt alınamayan durumlarda, hastaya takılan santral venöz kateter ile santral venöz basınç, arteriyel kateter ile invaziv arter kan basıncı monitörize edilir.

Sepsiste hemşirelik bakımı.
Hava yolu açıklığının sağlanması
Oksijen (geri dönüşümsüz oksijen maskesi, CPAP veya endotrakeal) tedavisinin uygulanması
Monitörizasyon uygulanması
Venöz olarak 2 damar yolu açılması
Önerilen sıvıların uygulanması
Kan şekeri kontrolüne uygun olarak idame sıvı başlanması
Kan kültürü alınarak önerilen antibiyotiğin uygulanması
Sıvı tedavisine yanıtla göre gerekirse, vazopressör, inotrop desteğinin verilmesi, ayrıca steroid tedavisi ve hastanın kan sonuçlarına göre kan veya kan bileşenlerinin verilmesi
Gerekirse mekanik ventilasyon için hazırlığın yapılması
Uygun şekilde hastanın beslenmesi
Ciddi solunum yetmezliği ve ciddi septik şok olgularında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) tedavisi gerekebilir, bunun için hazırlık yapılması
Hastanın tüm fizyolojik parametreleri, laboratuvar sonuçları ve tedaviye yanıtın gözlenmesi

❖ SIVI TEDAVİSİ

- Sıvıların hızlı bir şekilde hazırlanarak hastaya verilmesi ve tedaviye yanıtının gözlenmesidir.
- Bu hastalarda acil olarak yapılması gereken girişimlerden biri de en az iki geniş venden damar yolu açılmasıdır.
- İlk 2 dakika içerisinde veya 3 denemede damar yolu açılmayan hastalarda intraosseoz (kemik içi) yol açılmalı ve sıvılar hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.
- Sepsiste dolaşımdaki kan miktarının azalmasına bağlı olarak kalbin pompalama gücü azalır.
- Dolaşımdaki kan miktarının arttırılması için sıvı desteği yapılmaktadır
- Sıvı tedavisi uygulanan hastaların kan şekeri takibi yapılmalı ve gerekirse kan şekerinin düzeyine göre sıvıların glikoz düzeyinin arttırılması sağlanır.
- Hastanın ayrıca idrar miktarının takibi için idrar sondası takılarak aldığı çıkardığı takibi yapılmalıdır.

İLAÇ TEDAVİSİ

Sepsis ve septik şokta sıvı tedavisine yanıt alınamadığında ve ortalama arteriyel kan basıncına göre farmakolojik tedaviler uygulanır.

- Sepsiste erken, hedefe yönelik tedavinin mortaliteyi %16 azalttığı,
- inotrop başlanmasında gecikmenin mortaliteyi 2 kat artırdığı,
- hemodinamik bozukluğu düzeltmede protokole bağlı kalınmasının mortaliteyi %40 azalttığı bildirilmektedir.

Vazopressör İlaçlar

- En çok dopamin
- Epinefrin,
- Norepinefrin,
- Vazopressin
- Anjiotensin kullanılırken

İnotrop olarak ise;

- Dobutamin,
 - Orta doz dopamin,
 - Epinefrin
 - Fosfodiesteraz inhibitörleri (milrinon ve amrinon)
- kullanılır.

- Hemşirenin bu ilaçları hazırlarken, uygularken ve etkisini değerlendirirken çok önemli sorumlulukları vardır.
- Bu ilaçların hastaya bir pompa yardımıyla verilmesi ve hastanın fizyolojik parametrelerinin yakından izlenmesi gerekir.
- Vazoaktif ilaçların dozlarının yanlış, eksik hesaplanması hastaya zarar verir ve mortaliteyi artırır.
- İnotrop ilaç kullanımında arteriyel monitorizasyon ve ideal olarak kalp debisi izlenmelidir.
- İnotrop ilaçlar %0,9 NaCl ile dilüe edilmelidir.
- Bu ilaçlar mümkün ise mutlaka santral kateterlerden verilmeli,
- ilaçların verildiği kateter lümeninden başka bir sıvı verilmemeli ve test için kan alınmamalıdır.
- İlaçlar periferik kateterlerden veriliyor ise en kısa zamanda santral kateter açılmalıdır.
- Hasta stabilize olduktan sonra 1 saat içinde antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.
- Önerilen antibiyotik tedavisi uygulanmadan önce mutlaka kan kültürü alınarak uygun şartlarda laboratuvara gönderilir.
- Mekanik ventilasyon uygulanan hastalara entübasyon sırasında veya sonrasında önerilen sedasyon ve analjezikler uygulanır.

BESLENME

- Malnütrisyon, immün fonksiyonların bozulmasına ve dolayısıyla enfeksiyon riskinin artmasına, buna bağlı olarak mortalite/morbiditenin artmasına ve hastanede kalış süresinin uzamasına neden olur.
- Oysa yeterli beslenen hastalarda fizyolojik stabilite ve iyileşme olur
- Beslenme gereksinimleri, tolere edebilen hastalarda beslenme oral veya enteral olarak sağlanmalıdır.
- Enteral beslenmeyi tolere edemeyen hastaların beslenmesi parenteral olarak sağlanır. Ancak parenteral beslenmenin tek başına değil de enteral beslenmeyle birlikte yapılması önerilmektedir.

- Erken enteral beslenmenin;
 - ❖ *Nitrojen dengesini geliřtirdiđi,*
 - ❖ *Yara iyileřmesi*
 - ❖ *İmmün fonksiyonları desteklediđi,*
 - ❖ *Selüler antioksidan sistemi arttırdıđı,*
- Enteral besleme yolunun seřiminin Ventilatör iliřkili pnömoni (VİP) geliřimi aēısından önemli olduđu vurgulanmaktadır.
- Enteral beslenme sondasının duodenuma yerleřtirilmesinin mikroaspirasyon, gastroözafagial reflüyü azalttıđı ve beslenme toleransını arttırdıđı bildirilmektedir.
- Erken dönemde gastrik besleme ve intestinal besleme yolunun karřılařtırıldıđı bir metaanaliz çalıřmasında VİP aēısından iki besleme yolu arasında bir fark olmadıđı ortaya konmuřtur.

HİJYEN

- Uygun solüsyonlar ile ağız bakımı,
- Vücut bakımı,
- Göz bakımı gibi bakımlar yer almaktadır.
- Göz bakımı yapılan sedatize olan hastaların gözlerinin nemlenmesi için belirli aralıklarla suni gözyaşı damlalarının kullanılması ve gözlerin göz bandı ile kapatılması kornea ülserleri gelişmesini önleyecek girişimlerdir.
- Hastaların günlük vücut bakımları
- Cilt değerlendirmeleri yapılmalıdır.

SEPSİSİN ÖNLEMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

*Eğitim

*El hijyeni

*Nasokomiyal enfeksiyonların takibi

Ventilatör ilişkili pnömoninin (VİP) önlenmesi

Kateter ilişkili enfeksiyonların (Kİİ) önlenmesi

Üriner kateter ile ilişkili enfeksiyonların (ÜKİİ) önlenmesi

Cerrahi girişim enfeksiyonun önlenmesi

- **Eğitim:** Sağlık çalışanları sepsis ve önleme yolları konusunda eğitilmeli ve bu eğitimler periyodik olarak devam ettirilmelidir. YBÜ’de eğitilmiş ve yeterli sayıda hemşire bulundurulmalıdır.
- **El hijyeni:** Hasta ile her temas öncesi ve sonrası el yıkanması, ayrıca hasta ile temas öncesi eldiven takılması önerilmektedir. Alkol içerikli el antiseptiklerinin kullanımının enfeksiyon oranını azalttığı bildirilmektedir.

Nasokomiyal enfeksiyonların takibi:

- Yoğun bakımda enfeksiyonların önlenmesi ile sepsisin oluşumu engellenebilir.
- Hastane enfeksiyonlarının azaltılması veya önlenmesinde enfeksiyon izlemlerinin sürekli yapılması önemlidir.
- Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon oluşumuna neden olan en önemli etken hastaya yapılan invaziv girişimlerdir.
- Bu nedenle dikkat edilmesi gereken enfeksiyon kaynakları;

❖ **Ventilatör ilişkili pnömoninin (VIP) önlenmesi**

❖ **Üriner kateter ile ilişkili enfeksiyonların (ÜKİİ) önlenmesi**

❖ **Ventilatör ilişkili pnömoninin (VİP) önlenmesi:** VİP'in önlenmesi için hastalar uzun yatırılmamalı ve ventilatör tedavisi mümkün olan en kısa zamanda sonlandırılmalıdır. Önlem paketi içerisinde;

- Ventilatör devrelerinin gözle görülür kirlenme olunca değiştirilmesi,
- Aspirasyon uygulamalarının gereksinimlere göre yapılması,
- Her 2-4 saatte bir ventilatör devrelerindeki sıvı birikiminin kontrol edilerek boşaltılması,
- Hasta ve hastada kullanılan malzemeler ile temastan önce ve sonra ellerin yıkanması,
- Hasta çıktıları ile temastan önce eldiven giyilmesi, her 2-4 saatte bir klorheksidin ile ağız bakımı yapılması,
- Ağız içerisinde biriken sekresyonların gerektiğinde aspire edilmesi,
- Hastanın başı 30-45C yükseltilerek yatırılması,
- Her pozisyon öncesi ventilatör devrelerindeki sıvının boşaltılması,
- Nemlendiricinin günde bir değiştirilmesi,
- Endotrakeal tüp kaf basıncının > 20, < 30 cmH₂O arasında tutulması,

❖ Kateter ilişkili enfeksiyonların (Kİİ) önlenmesi:

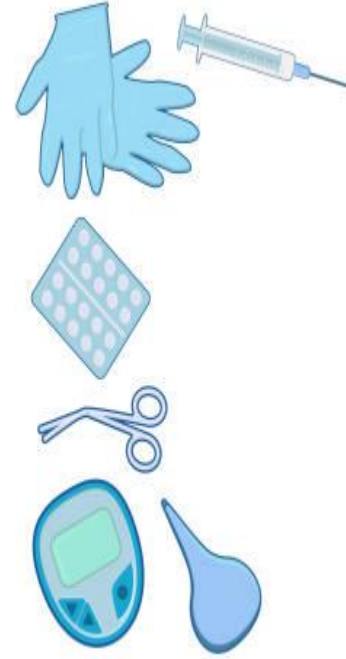
- Hastaya gerekli olan en az sayıda lümene sahip kateterler takılmalı,
- kateter takılması sırasında “maksimum bariyer önlemleri” alınmalıdır.
- Kateter bakımının yapıldığı ürün kadar kateterin kapatılması için kullanılacak ürünlerde enfeksiyonu etkilemektedir.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kateter bakımında klorheksidin (sürekli kateterizasyondan kaçınmak, uygun el hijyeninin sağlanması, kateter bakımında uygun antiseptiklerin kullanılması, kateter girişimlerinin steril şartlarda yapılması ve uygun kapama örtülerinin kullanılması gibi hemşirelik.
- Kateter bölgesine uygulanan şeffaf pansumanların 7 günde bir, gazlı bez pansumanların ise 48 saatte bir değiştirmesi gerekir.
- Sağlık personelinin intravasküler kateter enfeksiyon bulguları, uygulama teknikleri,
- Kİİ önleme ve kontrol önlemleri konusunda eğitimi ve periyodik olarak bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi sağlanmalıdır.

❖ Üriner kateter ile ilişkili enfeksiyonların (ÜKİİ) önlenmesi:

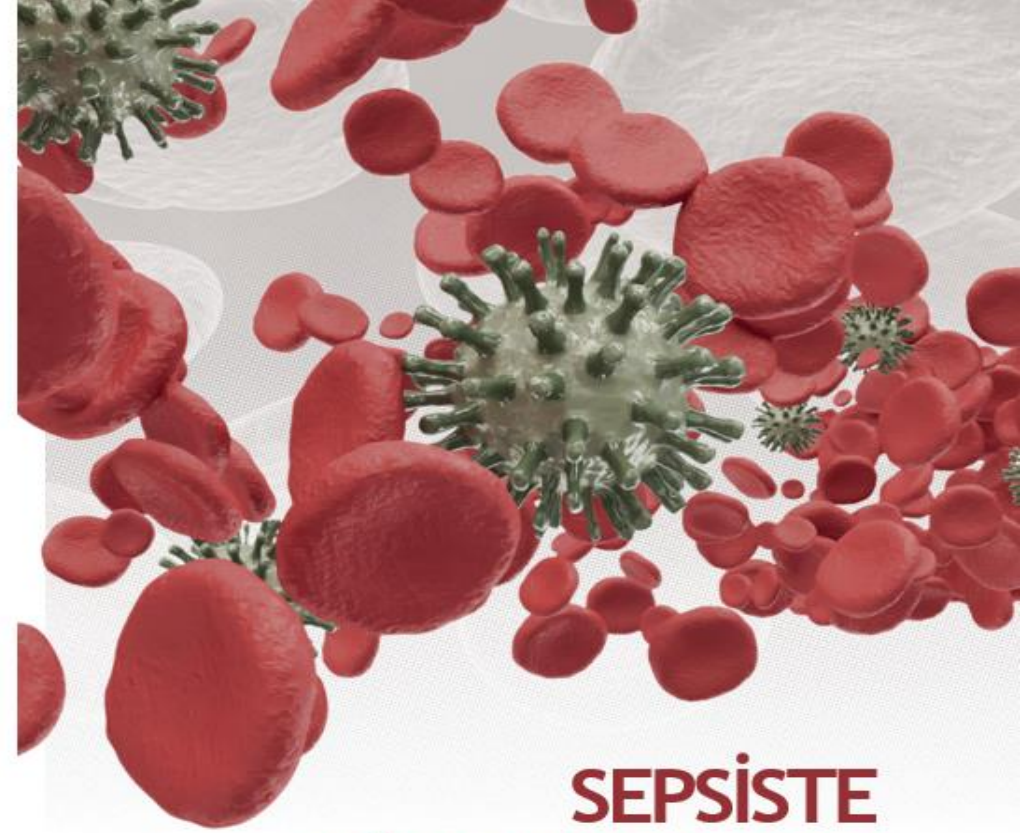
- Uzun süreli kateterizasyondan kaçınma,
- Gereksiz durumlarda kateteri çıkarma,
- Hastaların bakımında uygun el hijyeninin sağlanması,
- Kateter bakımında uygun solüsyonların kullanılması,
- Transport zamanında idrar torbasının yatak seviyesinin altında tutulması,
- Üriner kateter takılması ve değişiminin steril şartlarda yapılması
- CDC üriner kateter temizliğinde sabunlu su, distile su veya povidon iyod kullanılmasını önermektedir.

❖ Cerrahi girişim enfeksiyonun önlenmesi:

- Enfeksiyonların önlenmesinde cerrahi girişimden bir saat önce antimikrobal profilaksi uygulanması önerilmektedir.
- Cerrahi girişim yapılacak bölge saçlı deri ise elektrikli traş malzemeleri ile kıllar temizlenmelidir.
- Elektif cerrahi uygulamaları öncesi hastaların enfeksiyon durumları tanılanmalı ve enfeksiyon var ise tedavi edildikten sonra cerrahi girişimler planlanmalıdır.



- A. BAŞLANGIÇ RESÜSİTASYONU
- B. SEPSİSTE TARAMA VE PERFORMANS GELİŞTİRME
- C. TANI
- D. ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ
- E. KAYNAK KONTROLÜ
- F. SIVI TEDAVİSİ
- G. VAZOAKTİF MEDİKASYONLAR
- H. KORTİKOSTEROİDLER
- I. KAN ÜRÜNLERİ
- J. İMMÜNGLOBÜLINLER
- K. KANIN PURİFİKASYONU
- L. ANTİKOAGÜLAN AJANLAR
- M. MEKANİK VENTİLASYON
- N. SEDASYON VE ANALJEZİ
- O. GLUKOZ KONTROLÜ
- P. RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ
- Q. BİKARBONAT TEDAVİSİ
- R. VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ
- S. STRES ÜLSER PROFİLAKSİSİ
- T. NÜTRİSYON
- U. HASTA BAKIM HEDEFLERİNİ OLUŞTURMA



SEPSİSTE SAĞKALIM KAMPANYASI 2016 TEDAVİ KILAVUZU ÖZETİ

Araştırma Makalesi/ Research Article

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Sepsis Bilgisi ve Farkındalığı: Çok Merkezli Bir Çalışma

Level of Sepsis Knowledge and Awareness of Intensive Care Unit Nurses: A Multicenter Study

Yayın Dalli¹ ID Seda Pehlivan² ID Halil Erkan Sayan³ ID
Mazhar Serbes⁴ ID Beyza Nur Kahraman⁵ ID

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği
2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği
3. ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4. Ak Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Tıp
5. Ahya Şehir Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Kütüphane
of receipt: 20/08/2024 Kabul tarih: 20/08/2024
ity of Health Sciences, Department of Nursing

Amaç: Bu çalışmanın amacı, YBÜ hemşirelerinin sepsis bilgisi ve farkındalığını güncel sepsis bakım paketi önerileri çerçevesinde değerlendirmektir.

Sonuç: Bu çalışma, YBÜ hemşirelerinin sepsisi tanıma ve yönetimine ilişkin bilgilerinde eksik olduğu yönleri vurgulamıştır. Sağlık kurumlarının ve YBÜ hemşireliği ile ilgili derneklerin sepsis ile ilgili tekrarlı eğitimler sağlamasına ve içeriğinde güncel kanıta dayalı bilgi ve uygulamalara yer vermesine ihtiyaç vardır.

Yöntem: Bu çok merkezli kesitsel araştırma, Türkiye'deki üç kamu hastanesinin erişkin YBÜ'lerinde çalışan ve en az bir yıl deneyimi olan 275 hemşire ile Haziran 2023-Aralık 2023 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın verileri, Hemşire Tanıtım Formu ve Sepsis Bilgi ve Farkındalık Anketi ile toplandı.

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) görülen en yaygın komplikasyonun sepsis olduğunu bilmesi ve uygun şekilde yönetebilmesi için yeterli bilgiye sahip olması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, YBÜ hemşirelerinin sepsis bilgisi ve farkındalığını güncel sepsis bakım paketi önerileri çerçevesinde değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çok merkezli kesitsel araştırma, Türkiye'deki üç kamu hastanesinin erişkin YBÜ'lerinde çalışan ve en az bir yıl deneyimi olan 275 hemşire ile Haziran 2023-Aralık 2023 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın verileri, Hemşire Tanıtım Formu ve Sepsis Bilgi ve Farkındalık Anketi ile toplandı.

Bulgular: Sepsis tanımı, sepsise yönelik belirtiler (%44) ve sepsis risk faktörleri (%44) en çok yanlış bilinen konulardır. Sepsis tanımı ve belirtilerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi orta düzeydeydi.

Sonuç: Bu çalışma, YBÜ hemşirelerinin sepsisi tanıma ve yönetimine ilişkin bilgilerinde eksik olduğu yönleri vurgulamıştır. Sağlık kurumlarının ve YBÜ hemşireliği ile ilgili derneklerin sepsis ile ilgili tekrarlı eğitimler sağlamasına ve içeriğinde güncel kanıta dayalı bilgi ve uygulamalara yer vermesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, sepsis, farkındalık, bilgi.

ABSTRACT:

Objective: It is important that nurses have sufficient knowledge to recognize and manage sepsis patients. The purpose of this study was to evaluate the sepsis knowledge and awareness of ICU nurses in Turkey.

Methods: This multicenter cross-sectional study was conducted in the adult ICUs of three public hospitals in Turkey between June 2023 and December 2023 with 275 nurses with at least one year of experience working in ICUs. The data were collected with the Nurse Introduction Form and Sepsis Knowledge and Awareness Questionnaire.

Results: The self-confidence in recognizing and managing sepsis patients was 16.19±5.25 points. According to the sepsis knowledge test, the mean score of the questions was 12.40±1.97. The questions with the lowest correct answers were early signs of sepsis

Surviving Sepsis Campaign

Surviving Sepsis
Campaign:
International
Guidelines for
Management of
Sepsis and Septic Shock

SEPSIS
KILAVUZU
2021